G 시즌2 독립 취재

제70부작 · 응급실 대기 시간의 진실

1037~1041화 (총 5화)

공립병원 응급실 대기 시간 통계 조작과 환자 사망, 데이터 저널리즘

1037화 · 부작 내 1화

새로운 취재. 신문사 독자 메일함에 한 통의 편지가 도착합니다. 마드리드 남부 몬테스클라로스 지구에 사는 페트라 리사라수가, 가슴 통증으로 응급실을 찾은 아버지가 일곱 시간을 기다린 끝에 숨졌다고 호소합니다. 알바로는 병원 근처 카페에서 그녀를 만나고, 하비에르는 '같은 증상이라도 동네에 따라 대기 시간이 다르다'는 가설을 데이터로 검증하자고 제안합니다.

Álvaro: (Se sienta frente a ella en una cafetería con vistas a la entrada de urgencias del Hospital Los Almendros) Gracias por venir, Petra. Sé que no es fácil volver aquí.

Petra: (Con las manos alrededor de una taza que no toca) Paso por esta puerta todos los días para ir al trabajo. No tengo otro camino. Así que da igual.

Álvaro: En su correo decía que su padre llegó a urgencias un martes de enero. ¿Puede contarme qué pasó desde el principio?

Petra: Mi padre, Clemente, tenía setenta y cuatro años. Hipertenso, con el colesterol alto, nada fuera de lo normal para su edad. Esa tarde empezó con un dolor en el pecho que le bajaba por el brazo izquierdo.

Álvaro: ¿Llamaron al 112?

Petra: Llamamos. Nos dijeron que había mucha demanda y que, si podía caminar, era más rápido traerlo en coche. Lo trajo mi marido. Entramos a las seis y diez de la tarde.

Álvaro: ¿Y en el triaje? ¿Qué le dijeron?

Petra: Una enfermera le tomó la tensión y el pulso, le preguntó cuánto le dolía del uno al diez. Mi padre dijo ≪un seis≫, porque él era así, nunca se quejaba. Le pusieron una pulsera amarilla.

Álvaro: Amarillo, en el sistema de triaje que usan aquí, es el nivel tres: urgente, pero no inmediato.

Petra: Eso lo he aprendido después. En ese momento no sabía nada de colores. Solo sabía que la sala estaba llena, que había gente de pie y camillas en el pasillo.

Álvaro: ¿Le hicieron un electrocardiograma al llegar?

Petra: No. Esa es la pregunta que me hago todas las noches. El electro se lo hicieron a la una menos cuarto de la madrugada. Casi siete horas después.

Álvaro: (Anota, despacio) Siete horas para un electrocardiograma, con dolor torácico.

Petra: Lo pusieron en una camilla en el pasillo. A las doce y media se desplomó. Lo reanimaron, lo subieron a la UCI. Murió a las cuatro de la mañana. Infarto agudo de miocardio, pone el informe.

Álvaro: Lo siento mucho, Petra.

Petra: No le he escrito para que lo sienta. Le he escrito porque mi cuñada vive en el norte de Madrid. Su suegro tuvo lo mismo un mes después, los mismos síntomas, en el Hospital Santa Engracia. Le hicieron el electro en veinte minutos. Hoy está vivo, jugando a la petanca.

Álvaro: Dos casos no prueban una diferencia sistemática. Usted lo sabe, ¿verdad?

Petra: Lo sé. Por eso no he ido a otro periódico que me haga un reportaje lacrimógeno con una foto de mi padre. Quiero saber si lo que le pasó a él es lo normal aquí. Si en mi barrio se espera más que en el de mi cuñada.

Álvaro: Entonces vamos a intentar averiguarlo con datos. No le prometo un resultado concreto. Puede que los números digan otra cosa.

Petra: Prefiero una verdad incómoda a una mentira que me consuele.

Álvaro: Una última cosa. ¿Han presentado reclamación en el hospital?

Petra: Una hoja de reclamaciones en el servicio de atención al paciente. Me contestaron con una carta tipo: ≪La atención se ajustó a los protocolos vigentes≫. Tres líneas.

Álvaro: ¿Me la podría enviar? Y el informe de exitus, si está dispuesta.

Petra: Se lo mando esta noche. (Se levanta) Mi padre era conductor de autobús. La línea que pasa por delante de esta puerta. Treinta años.

Javier: (Esa misma tarde, en la redacción, con el correo de Petra abierto en dos pantallas) Lo primero, Álvaro: esto no se cuenta con una historia. Se cuenta con miles de historias convertidas en números.

Álvaro: Por eso te lo traigo a ti. ¿Qué datos existen?

Javier: Cada vez que alguien entra en urgencias, el sistema registra una hora de llegada, una hora de triaje, un nivel de prioridad, una hora de primera atención médica y una hora de alta o ingreso. Todo con fecha y minuto.

Álvaro: ¿Y es público?

Javier: Agregado, en parte. La Consejería publica un informe anual con ≪tiempos medios de demora≫. Una sola cifra por hospital. No distingue por nivel de triaje ni por motivo de consulta.

Álvaro: Una media por hospital no nos dice nada sobre el dolor torácico.

Javier: Nada. Y además la media engaña: tres pacientes que esperan doce horas inflan la cifra de todo el mes. Lo que necesitamos es la mediana y, sobre todo, el percentil noventa.

Álvaro: Explícamelo como si fuera un lector un domingo por la mañana.

Javier: La mediana es el paciente del medio: la mitad espera menos que él y la mitad, más. El percentil noventa es el que te dice cómo les va a los peor parados: nueve de cada diez esperan menos que esa cifra, uno de cada diez espera más.

Álvaro: Y el padre de Petra estaría en ese uno de cada diez.

Javier: Probablemente. Lo que quiero saber es si ese ≪uno de cada diez≫ en Los Almendros espera el doble, el triple, o lo mismo que en Santa Engracia.

Álvaro: ¿Cómo conseguimos los datos desagregados?

Javier: Con una solicitud de acceso a la información pública. Registros anonimizados de los últimos tres años, de los once hospitales públicos de la región: nivel de triaje, motivo de consulta codificado, y las cinco horas que te he dicho.

Álvaro: ¿Nos los van a dar?

Javier: Tienen un mes para contestar, ampliable a otro. Lo más probable es que nos digan que hace falta una ≪acción previa de reelaboración≫ y que lo rechacen.

Álvaro: ¿Y entonces?

Javier: Entonces reclamamos ante el Consejo de Transparencia. Tarda, pero suele dar la razón cuando los datos ya existen en una base de datos y solo hay que exportarlos.

Álvaro: Redáctala de forma que no puedan escudarse en eso. Que quede claro que no pedimos un informe, pedimos una extracción.

Javier: Ya la tengo a medias. (Gira la pantalla) Mira: ≪Se solicita la extracción, en formato reutilizable, de los registros individuales anonimizados…≫. Y pido expresamente que eliminen edad exacta y código postal, para que no puedan alegar protección de datos.

Álvaro: Pide la edad en tramos de diez años. Si no, no podremos comparar poblaciones parecidas.

Javier: Bien visto. Tramos de diez años. (Teclea) Y el sexo. Las mujeres con infarto suelen consultar con síntomas menos típicos. Si no lo controlamos, nos lo echarán en cara.

Álvaro: Mientras esperamos, yo empiezo por la otra punta. Gente que trabaje dentro de esas urgencias.

Javier: Cuidado con eso. Los sanitarios están quemados y con razón, pero el que habla con la prensa sin permiso se juega un expediente.

Álvaro: Lo sé. Iré despacio. (Mira la foto que Petra le ha enviado: un hombre con uniforme de conductor, sonriendo junto a un autobús) Clemente Lizarazu. Setenta y cuatro años. Siete horas.

Javier: Cuando tengamos los datos, Clemente será una fila de la tabla. Una entre cientos de miles.

Álvaro: Y precisamente por eso no podemos equivocarnos en ninguna.

1038화 · 부작 내 2화

5주 후, 컨세헤리아(지방 보건부)가 정보공개 청구에 일부만 응답하고, 하비에르는 투명성위원회에 이의신청을 냅니다. 그 사이 알바로는 로스 알멘드로스 응급실 간호사 아란차 레스카노를 만나 과밀 상황을 듣고, 하비에르의 첫 분석 결과가 나옵니다.

Javier: (Deja caer un folio impreso sobre la mesa de Álvaro) Ha llegado la respuesta. Adivina.

Álvaro: ¿Rechazada?

Javier: Estimada parcialmente. Que en la jerga quiere decir ≪te damos la mitad y te damos las gracias≫. Nos dan hora de llegada, nivel de triaje y hora de alta. Pero no el motivo de consulta ni la hora de primera atención médica.

Álvaro: Sin motivo de consulta no podemos aislar el dolor torácico.

Javier: Exacto. Alegan que el campo ≪motivo≫ es texto libre y que anonimizarlo supondría reelaboración. Mentira a medias: el motivo se codifica con el propio sistema de triaje. Hay un diagrama para dolor torácico, otro para disnea, otro para cefalea. Es un código, no un texto.

Álvaro: ¿Lo puedes demostrar?

Javier: El manual de triaje es público, lo publica la propia Consejería en su intranet para formación. Lo he adjuntado a la reclamación ante el Consejo de Transparencia. Presentada esta mañana.

Álvaro: ¿Cuánto puede tardar?

Javier: Tres meses de plazo legal. En la práctica, a veces más.

Álvaro: No podemos esperar tres meses sin hacer nada.

Javier: No vamos a esperar. Con lo que nos han dado ya puedo hacer algo: comparar el tiempo total en urgencias para el nivel tres, en todos los hospitales. No es dolor torácico, pero es la

misma prioridad que le dieron a Clemente.

Álvaro: Hazlo. Yo tengo una cita esta tarde.

Arantxa: (En un banco de un parque, a dos calles del hospital, todavía con el pijama sanitario bajo el abrigo) Tengo veinte minutos. Si alguien me ve aquí con usted, he venido a fumar.

Álvaro: No fuma, ¿verdad?

Arantxa: Lo dejé hace diez años. Pero en urgencias nadie se fija en esas cosas. (Mira alrededor) ¿Esto es anónimo de verdad?

Álvaro: Su nombre no aparecerá en ningún sitio. Si en algún momento algo de lo que me diga pudiera identificarla, se lo consultaré antes.

Arantxa: Llevo diecinueve años de enfermera, once en Los Almendros. Antes estuve en el norte. Le puedo decir que no es el mismo trabajo, aunque el uniforme sea igual.

Álvaro: ¿Qué cambia?

Arantxa: La cuenta es sencilla. En Los Almendros tenemos veintidós boxes para un área de casi cuatrocientos mil habitantes. En el norte, cuando yo trabajaba allí, eran treinta y tantos boxes para menos gente. Y aquí la población es más mayor y más enferma.

Álvaro: ¿Y el personal?

Arantxa: Un turno de noche normal: seis enfermeras para entre sesenta y ochenta pacientes a la vez. Hay noches que llegamos a cien. La ratio recomendada en urgencias sería de una enfermera por cada cuatro o cinco pacientes en la zona de boxes.

Álvaro: Es decir, cada enfermera atiende el triple de pacientes de lo recomendado.

Arantxa: Más del triple, en las noches malas. Y el triaje lo hace una sola enfermera. Una. Con la cola llegando hasta la puerta.

Álvaro: El padre de la mujer con la que hablé llegó con dolor torácico y recibió un nivel tres. Amarillo.

Arantxa: (Suspira) El dolor torácico con alguna característica de riesgo debería ser naranja, nivel dos. Pero si el paciente dice un seis, si no suda, si la tensión está bien, el diagrama te lleva a amarillo. Y en amarillo, en Los Almendros, puedes esperar cuatro o cinco horas a que te vea un médico.

Álvaro: ¿El electrocardiograma no se hace en el triaje?

Arantxa: El protocolo dice que todo dolor torácico debe tener un electro en los primeros diez minutos. Lo dice el papel. Pero tenemos un electrocardiógrafo en la zona de triaje y otro en boxes, y el de triaje se lo llevan cada dos por tres porque falta en otro sitio.

Álvaro: ¿Eso se registra en algún sitio? ¿La hora del electro?

Arantxa: En la historia clínica, sí. Cada electro lleva la hora impresa en el papel y se escanea. Si alguien quisiera, podría sacar cuántos dolores torácicos han tenido el electro en menos de diez minutos.

Álvaro: ¿Y alguien lo ha sacado?

Arantxa: Hay un indicador interno, sí. Lo vemos en las reuniones de calidad. El último que vi estaba en un treinta y pico por ciento de cumplimiento. En el norte, que yo sepa, rondan el ochenta.

Álvaro: ¿Tiene ese documento?

Arantxa: No. Y aunque lo tuviera, no se lo daría. Sería como firmar con mi nombre. (Se levanta) Pídalo. Ustedes saben pedir esas cosas, ¿no? Se llama ≪indicador de demora del ECG en dolor torácico≫. Que lo pidan tal cual.

Álvaro: Gracias, Arantxa.

Arantxa: No me dé las gracias. Haga que lo publiquen. Estamos cansadas de ser nosotras las que ponemos la cara cuando alguien muere en un pasillo.

Javier: (Esa noche, por videollamada, con un gráfico en la pantalla compartida) Vale. Primeros resultados. Nivel tres, tiempo total desde la llegada hasta el alta o el ingreso. Tres años de datos, más de un millón de visitas en nivel tres.

Álvaro: ¿Y?

Javier: Santa Engracia: mediana de dos horas y cuarenta minutos. Los Almendros: cinco horas y cincuenta. Más del doble.

Álvaro: ¿Y el percentil noventa?

Javier: Ahí es donde se dispara. En Santa Engracia, el diez por ciento que más espera pasa más de cinco horas. En Los Almendros, más de catorce horas.

Álvaro: Catorce horas. Casi el triple.

Javier: Y no es solo Los Almendros. Los cuatro hospitales del sur están en la mitad peor de la tabla. Los tres del norte, en la mitad mejor. Si pinto un mapa, la línea la marca la autovía.

Álvaro: Eso es un titular.

Javier: Todavía no. (Levanta un dedo) El tiempo total incluye el tiempo que el paciente pasa esperando cama para ingresar. Si en el sur ingresan a más gente, porque la población está más enferma, el tiempo total sube aunque la atención inicial sea igual de rápida.

Álvaro: Por eso necesitamos la hora de primera atención médica.

Javier: Y el motivo de consulta. Sin eso, lo que tengo es una sospecha muy bien dibujada.

Álvaro: Entonces añade una segunda solicitud. El indicador de demora del electrocardiograma en dolor torácico, por hospital, últimos tres años. Me han dado hasta el nombre exacto.

Javier: (Lo apunta) ¿Fuente interna?

Álvaro: Alguien que se juega mucho. No preguntes más.

1039화 · 부작 내 3화

석 달 후, 투명성위원회가 신문사의 손을 들어주고, 완전한 데이터가 도착합니다. 하비에르의 분석은 '네 배'라는 충격적인 수치를 보여 주지만, 역학자 네레아 올라바리아가 검토 과정에서 두 병원의 기록 방식이 다르다는 치명적인 문제를 찾아냅니다. 편집장은 헤드라인을 서두르고, 알바로는 숫자를 다시 계산하기로 합니다.

Javier: (Entra en la sala de reuniones con el portátil abierto, sin quitarse el abrigo) El Consejo de Transparencia nos ha dado la razón en todo. Motivo de consulta codificado, hora de primera atención médica, todo. Y el indicador del electrocardiograma ha llegado esta mañana.

Álvaro: ¿Y?

Javier: Siéntate. Dolor torácico, nivel tres. Tiempo desde la llegada hasta que te ve un médico. Santa Engracia: mediana de treinta y ocho minutos. Los Almendros: dos horas y treinta y un minutos.

Álvaro: Eso es…

Javier: Cuatro veces más. Casi exacto. Y el percentil noventa: una hora y media en Santa Engracia frente a seis horas y cuarto en Los Almendros. Otra vez, cuatro veces.

Jefe: (Desde la puerta, con un café en la mano) He oído ≪cuatro veces≫. Repítemelo despacio.

Javier: Un vecino del sur con dolor en el pecho espera cuatro veces más que uno del norte para que lo vea un médico.

Jefe: Eso es portada. Eso es portada el domingo con un mapa a toda página. ¿Cuándo lo tenéis?

Álvaro: Antes quiero que lo revise alguien de fuera. Alguien que conozca cómo se registran estos datos.

Jefe: ¿Dudas de Javier?

Álvaro: No dudo de Javier. Dudo de los datos que nos han dado. Si la Consejería encuentra un fallo metodológico, no rectificaremos una cifra: perderemos la historia entera.

Jefe: Tienes una semana. Y quiero el mapa listo.

Nerea: (Dos días después, en su despacho de un departamento universitario de salud pública, rodeada de pantallas) He estado con vuestros ficheros todo el fin de semana. El análisis de Javier está bien hecho. El problema no es el análisis.

Javier: Dímelo sin anestesia.

Nerea: El campo ≪hora de primera atención médica≫ no significa lo mismo en todos los hospitales. En Los Almendros lo rellena el médico cuando abre la historia en boxes. En Santa Engracia, desde hace dos años, se registra cuando el médico de la consulta rápida de triaje ve al paciente, aunque sea dos minutos, antes de mandarlo a la sala de espera.

Álvaro: O sea que en Santa Engracia el reloj se para antes.

Nerea: Mucho antes. Han implantado un modelo con un médico en el triaje. Es una buena práctica, por cierto. Pero hace que su ≪primera atención≫ no sea comparable con la de Los Almendros. Estáis comparando un vistazo con una exploración completa.

Javier: (Se pasa las manos por la cara) Lo he mirado diez veces y no lo he visto.

Nerea: No podías verlo. No está en los datos. Está en cómo funciona cada servicio. Me di cuenta porque conozco a la jefa de urgencias de Santa Engracia; publicó un artículo sobre ese modelo.

Álvaro: ¿Hay alguna forma de comparar de forma justa?

Nerea: Sí. La hora del electrocardiograma. Esa es objetiva: la imprime la máquina. Y es lo que de verdad importa en un dolor torácico. Cada minuto sin electro es un minuto en que un infarto puede pasar desapercibido.

Javier: El indicador que nos dieron va por hospital y por mes, no por paciente.

Nerea: Para lo que queréis contar, basta. Y luego hay que ajustar. La población del sur es más mayor. Si comparáis tal cual, os dirán que la diferencia se debe a la edad.

Álvaro: ¿Cuánto tardarías en hacer el ajuste?

Nerea: Con Javier, un par de días. Estandarización por edad y sexo, y un análisis de sensibilidad excluyendo los meses de gripe, que en el sur golpean más fuerte.

Javier: (Tras dos días de trabajo, de nuevo en la redacción) Ya está. Electrocardiograma en menos de diez minutos en pacientes con dolor torácico. Santa Engracia: setenta y nueve por ciento de cumplimiento. Los Almendros: veintiséis por ciento.

Álvaro: El triple.

Javier: Exactamente el triple. Y si miras el tiempo mediano hasta el electro: catorce minutos en el norte, cuarenta y uno en el sur. Casi el triple otra vez. Ajustado por edad y sexo, la diferencia apenas cambia.

Nerea: (Por videollamada) Y se sostiene quitando los meses de gripe. Es una diferencia robusta. No es la edad, no es la estación. Es el hospital.

Jefe: (Leyendo el borrador del titular por encima del hombro de Álvaro) ≪Tres veces menos probabilidades de un electro a tiempo≫. ¿Dónde ha ido mi ≪cuatro veces≫?

Álvaro: A la papelera. Era una comparación injusta.

Jefe: El cuatro vende más que el tres, Álvaro. Y la diferencia de tiempo de espera hasta el médico existe, aunque esté inflada.

Álvaro: Si publicamos el cuatro y la Consejería explica lo del médico en triaje, nos destrozan en una tarde. Y con razón. Y entonces nadie hablará del electrocardiograma, que es lo que mató a Clemente.

Jefe: (Se queda en silencio un momento) ¿Y el tiempo hasta el médico lo tiramos entero?

Nerea: No hace falta tirarlo. Se puede contar con honestidad: en Santa Engracia te ve un médico enseguida porque han reorganizado el triaje. En Los Almendros, no. Eso también es una diferencia, solo que de otro tipo.

Álvaro: Y de hecho es una pista: si una solución existe y funciona en el norte, ¿por qué no se ha implantado en el sur?

Jefe: Vale. El triple. Pero quiero el mapa igual.

Javier: El mapa sale igual. Solo cambia la leyenda.

Álvaro: (Cuando el jefe se va) Gracias, Nerea. Nos has salvado de un error muy caro.

Nerea: Os he salvado de publicar algo que habría sido verdad a medias. Que es casi peor que una mentira, porque cuesta mucho más desmontarla.

Camila: (Esa noche, en casa, con el portátil de Álvaro en las rodillas y la gráfica en pantalla) ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que la versión honesta es más dura que la exagerada.

Álvaro: ¿Por qué lo dices?

Camila: Porque ≪esperas cuatro veces más≫ suena a queja. ≪Tienes un tercio de probabilidades de que te hagan a tiempo la prueba que detecta un infarto≫ suena a lo que es: una decisión de dónde se pone el dinero.

Álvaro: ¿Me ayudas a escribirlo así sin que parezca un manual de estadística?

Camila: Empieza por Clemente. Termina por Clemente. Y en medio, una sola cifra por párrafo. Nadie recuerda dos porcentajes seguidos.

Álvaro: ¿Y cómo digo ≪el triple≫ sin que suene a eslogan?

Camila: Alterna. ≪El triple que≫, ≪tres veces más≫, ≪uno de cada cuatro frente a cuatro de cada cinco≫. Y una vez, solo una, la cifra en minutos: catorce frente a cuarenta y uno. Los minutos se entienden con el cuerpo.

Álvaro: (Escribe) ≪En el norte, el electro llega antes de que se enfríe un café. En el sur, te da tiempo a ver la primera parte de un partido≫.

Camila: (Se ríe sin ganas) Eso sobra. Pero vas por buen camino.

1040화 · 부작 내 4화

3주 후, 알바로가 로스 알멘드로스 응급실 의사 하산 벨카디를 인터뷰하고, 신문사 변호사 마르타와 함께 기사의 법률 검토를 진행합니다. 페트라는 아버지를 노란색으로 분류한 간호사의 이름을 기사에 넣어 달라고 요구하고, 알바로는 개인이 아닌 구조의 책임을 다루겠다며 거절합니다.

Hassan: (En la cafetería del hospital, al final de una guardia de veinticuatro horas, con ojeras profundas) Usted es el periodista que hace preguntas sobre los electros. Medio servicio lo sabe ya.

Álvaro: Espero no haberle causado problemas a nadie.

Hassan: A mí no. He decidido hablar con mi nombre. Soy adjunto de urgencias, llevo quince años aquí, y he firmado tres escritos internos sobre esto. Si me van a abrir un expediente por decir lo que ya he puesto por escrito, que lo hagan.

Álvaro: ¿Es consciente de las consecuencias?

Hassan: Mi padre vino de Nador a trabajar en la construcción. Levantó la mitad de los bloques que se ven desde esa ventana. No voy a callarme para proteger mi plaza mientras sus vecinos esperan en un pasillo.

Álvaro: Entonces vamos a lo concreto. ¿Por qué tarda tanto un electrocardiograma en Los Almendros?

Hassan: Por tres cosas. Primero, hay un solo enfermero de triaje para un volumen que pediría dos o tres. Segundo, el electrocardiógrafo de triaje es compartido. Tercero, no tenemos médico en el triaje, como en Santa Engracia. Lo pedimos hace dos años. Nos dijeron que no había presupuesto.

Álvaro: ¿Cuánto costaría?

Hassan: Un médico más por turno, más o menos. Cinco o seis contratos al año. Y un electrocardiógrafo fijo en triaje cuesta menos que un coche de gama media.

Álvaro: En los datos, el dolor torácico de nivel tres tarda una mediana de cuarenta y un minutos en tener su electro aquí. En el norte, catorce.

Hassan: Me lo creo. Y le diré algo que no está en sus datos: cuando el electro llega tarde, a veces el infarto ya no se ve igual. Hay infartos que dan un trazado claro al principio y luego se vuelven más difíciles de interpretar. Y la troponina, el marcador en sangre, tarda horas en subir. El electro precoz es nuestra mejor arma.

Álvaro: ¿Qué es exactamente un síndrome coronario agudo, para que lo entienda un lector?

Hassan: Que una arteria del corazón se ha cerrado del todo o en parte. Si es del todo, cada minuto muere músculo cardiaco. Por eso decimos que ≪tiempo es miocardio≫. Hay que abrir la arteria cuanto antes, con un cateterismo.

Álvaro: El caso que estoy siguiendo es el de un hombre de setenta y cuatro años, que esperó casi siete horas. No le pido que opine sobre él en concreto.

Hassan: Mejor, porque no lo haría sin leer su historia. Pero le diré lo que sé por estadística: en un hospital donde el electro se hace a tiempo una de cada cuatro veces, hay pacientes así. No uno. Varios cada año.

Álvaro: ¿La dirección conoce esos datos?

Hassan: Los ve cada trimestre en la comisión de calidad. Están en las actas. Pídalas.

Marta: (Esa tarde, en su despacho, con el borrador impreso lleno de anotaciones en rojo) Vamos por partes. Lo de los datos está blindado. Fuente oficial, metodología revisada por una experta independiente, y la habéis documentado. Bien.

Álvaro: ¿Y lo demás?

Marta: Lo demás es lo que me preocupa. Primero, los datos de salud de Clemente Lizarazu. Son datos especialmente protegidos. Necesito el consentimiento expreso y por escrito de Petra como heredera para publicar detalles del informe clínico.

Álvaro: Me lo ha dado de palabra.

Marta: De palabra no me sirve. Por escrito, con su firma y con la lista de lo que se va a publicar. Y aun así, solo lo imprescindible: hora de llegada, nivel de triaje, hora del electro, causa de la muerte. Ni antecedentes, ni medicación.

Álvaro: De acuerdo.

Marta: Segundo. Esta frase: ≪Clemente murió porque el electrocardiograma llegó tarde≫. No.

Álvaro: Es lo que sugiere todo.

Marta: Sugerir no es probar. No tenemos un perito que diga que con un electro a tiempo habría sobrevivido. Puede que el infarto fuera masivo y no hubiera nada que hacer. Si escribimos eso, el hospital nos demanda y, sobre todo, le hacemos a Petra una promesa que no podemos sostener.

Álvaro: ¿Cómo lo formulo?

Marta: Hechos encadenados, sin causalidad: ≪Llegó a las 18:10 con dolor torácico. El protocolo establece un electrocardiograma en diez minutos. Se le hizo a las 00:45. Murió a las 4:00≫. El lector sacará sus conclusiones. Y añade que la familia ha presentado una reclamación y que el hospital sostiene que se cumplieron los protocolos.

Álvaro: Que es mentira, según su propio protocolo.

Marta: Eso se lo preguntas a ellos en el derecho de réplica. Tercero: el doctor Belkadi. Habla con nombre. ¿Ha entendido que puede tener problemas disciplinarios?

Álvaro: Lo ha entendido mejor que nadie.

Marta: Que lo diga él en el texto. Y no le atribuyas nada que no esté grabado.

Petra: (Al día siguiente, en su casa, firmando el consentimiento sobre la mesa de la cocina) Hay una cosa que quiero que salga. La enfermera que le puso la pulsera amarilla. Se llamaba Magdalena, lo ponía en su tarjeta. Quiero que salga su nombre.

Álvaro: No va a salir, Petra.

Petra: ¿Por qué? Ella decidió que mi padre podía esperar.

Álvaro: Ella aplicó un diagrama con una cola de cuarenta personas, sola, en un turno en el que cada enfermera tenía el triple de pacientes de lo que debería. Los datos dicen que en ese hospital tres de cada cuatro dolores torácicos no tienen el electro a tiempo. No es Magdalena. Es el sistema.

Petra: El sistema no tiene cara. Magdalena sí.

Álvaro: Por eso mismo. Si ponemos su nombre, el reportaje será sobre ella. La Consejería dirá que fue un error individual, abrirá un expediente a una enfermera y no cambiará nada más. Y el año que viene habrá otro Clemente.

Petra: (Se queda mirando el papel mucho rato) Usted no ha visto a mi padre en esa camilla.

Álvaro: No. Y no voy a fingir que entiendo lo que siente. Pero sí le puedo decir lo que va a pasar con cada versión del reportaje. Y no quiero que su padre sirva para que castiguen a una persona en vez de arreglar un hospital.

Petra: (Firma, por fin) Que conste que no estoy de acuerdo. Lo acepto, pero no estoy de acuerdo.

Álvaro: Que conste. Y si cuando lo lea piensa que me he equivocado, quiero que me lo diga.

Petra: Se lo diré. No lo dude.

Javier: (Por la noche, en un mensaje de voz) He conseguido las actas de la comisión de calidad. Belkadi tenía razón: el cumplimiento del electro aparece en rojo en nueve de los últimos diez trimestres. Y en una de ellas, la dirección escribe: ≪Se elevará a la Consejería la necesidad de un facultativo en triaje≫. Fecha: hace veintidós meses.

Álvaro: ¿Y la Consejería contestó?

Javier: No hay rastro de respuesta en ninguna acta posterior. Ni una línea.

1041화 · 부작 내 5화

일주일 후, 알바로는 컨세헤리아의 의료지원국장 레안드로 살세도에게 반론권 인터뷰를 진행합니다. 살세도는 인구 구성과 독감 시즌을 탓하지만, 데이터 앞에서 일부를 인정합니다. 기사가 나가고 몇 주 뒤, 알바로와 페트라는 로스 알멘드로스 대기실에서 다시 만납니다.

Salcedo: (En su despacho de la Consejería, flanqueado por una jefa de prensa que toma notas) Señor Fuentes, le agradezco que nos haya enviado sus preguntas con antelación. No todos los medios lo hacen.

Álvaro: Es lo mínimo. Usted tiene derecho a responder antes de que publiquemos. Empiezo por la cifra central: en los últimos tres años, en Los Almendros solo el veintiséis por ciento de los pacientes con dolor torácico tuvo un electrocardiograma en los diez minutos que marca su propio protocolo. En Santa Engracia, el setenta y nueve.

Salcedo: Esa comparación no tiene en cuenta las características de la población. El área del sur tiene más personas mayores, más enfermedades crónicas, más frecuentación.

Álvaro: La hemos ajustado por edad y sexo, con una epidemióloga independiente. La diferencia se mantiene prácticamente igual. Le hemos enviado la metodología.

Salcedo: (Hojea un dosier) También está la gripe. Los picos de invierno golpean más al sur.

Álvaro: Lo hemos comprobado quitando los meses de gripe. La diferencia sigue siendo del triple.

Salcedo: Hay pacientes que acuden a urgencias por cuestiones que deberían resolverse en atención primaria. Eso satura el servicio.

Álvaro: Es cierto, y lo recogemos. Pero el paciente con dolor torácico no es uno de esos. Es exactamente el paciente para el que existen las urgencias.

Salcedo: Estoy de acuerdo en eso.

Álvaro: Entonces, ¿por qué no se cumple el protocolo?

Salcedo: Estamos trabajando en un plan de mejora integral de las urgencias del sur.

Álvaro: La comisión de calidad de Los Almendros pidió hace veintidós meses un médico en el triaje. Consta en las actas. ¿Qué respondió la Consejería?

Salcedo: (Mira a la jefa de prensa) Esa petición se valoró dentro del conjunto de necesidades de la red.

Álvaro: ¿Y cuál fue el resultado de esa valoración?

Salcedo: Que había otras prioridades.

Álvaro: ¿Cuáles?

Salcedo: No tengo aquí el detalle.

Álvaro: En ese mismo periodo, Santa Engracia recibió fondos para ampliar su modelo de médico en triaje. Consta en el portal de contratación. ¿Por qué allí sí y en Los Almendros no?

Salcedo: Santa Engracia presentó un proyecto piloto. Se aprobó por su calidad técnica.

Álvaro: ¿Se invitó a otros hospitales a presentar proyectos?

Salcedo: (Pausa larga) Fue una convocatoria interna.

Álvaro: ¿Los Almendros tuvo conocimiento de ella?

Jefa de prensa: El director general ha respondido ya a la cuestión.

Álvaro: Con todo respeto, no la ha respondido. Pero dejaré constancia de que esa es su respuesta.

Salcedo: (Se quita las gafas) Mire, señor Fuentes. Le voy a decir algo que no está en el dosier. Esa cifra del veintiséis por ciento no es aceptable. No lo es. Y no voy a defenderla.

Álvaro: ¿Puedo citarle?

Salcedo: Puede. Y puede añadir que antes de fin de año habrá un electrocardiógrafo fijo en cada triaje de la red y un plan para extender el médico en triaje a los hospitales del sur.

Álvaro: ¿Con qué presupuesto?

Salcedo: Eso lo concretaremos.

Álvaro: Lo publicaremos como un anuncio sin presupuesto asignado. Y volveremos a pedir el indicador dentro de seis meses.

Salcedo: Me parece justo.

Álvaro: Una última pregunta, sobre un caso concreto. Clemente Lizarazu, setenta y cuatro años, dolor torácico, siete horas hasta el electrocardiograma. La respuesta del hospital a la familia dice que se ajustó a los protocolos.

Salcedo: No puedo hablar de un paciente concreto.

Álvaro: No le pido datos clínicos. Le pregunto si un electro a las siete horas se ajusta al protocolo de diez minutos.

Salcedo: (Tras un silencio) No. No se ajusta.

Jefe: (Tres días después, a las ocho de la mañana, con el periódico abierto sobre la mesa de la redacción) Tercera noticia más leída del año, y ni siquiera llevamos veinticuatro horas. Y la Consejería ha convocado una rueda de prensa para las doce.

Javier: Y el Consejo de Transparencia ha publicado nuestra reclamación como criterio. A partir de ahora, el motivo de consulta se considera dato público.

Jefe: ¿Seguro que no queríais el ≪cuatro veces≫?

Álvaro: Nadie ha podido rebatir el tres. Con eso me basta.

Petra: (Seis semanas después, en la sala de espera de urgencias de Los Almendros, de noche, sentada junto a Álvaro) Han puesto una pantalla con el tiempo de espera estimado. Mírela. ≪Nivel tres: dos horas cuarenta≫.

Álvaro: La pusieron la semana pasada. Y hay un electrocardiógrafo nuevo en el triaje. Lo he visto al entrar.

Petra: Mi cuñada me llamó para decirme que había leído el reportaje y que lloró. Yo no he llorado. Lo he leído cuatro veces y no he llorado.

Álvaro: ¿Y lo de Magdalena? Le dije que me lo dijera si pensaba que me había equivocado.

Petra: (Mira hacia la ventanilla del triaje, donde una enfermera atiende a un hombre mayor) Esa es Magdalena. La vi la semana pasada, cuando vine a recoger unos papeles. Me reconoció. Se acercó y me dijo que se acordaba de mi padre. Que esa noche estuvo sola en triaje nueve horas.

Álvaro: ¿Qué le contestó?

Petra: Nada. No pude. (Pausa) No se había equivocado usted. Pero tampoco me pida que le dé las gracias por eso.

Álvaro: No se las pido.

Petra: La reclamación sigue su curso. Ahora tengo un abogado. Y tengo una cifra que nadie me puede discutir. Eso ya es más de lo que tenía en enero.

Álvaro: Dentro de seis meses volveremos a pedir el indicador. Si no ha mejorado, lo contaremos.

Petra: Y si ha mejorado, también. Que la gente sepa que se podía.

Megafonía: (Una voz metálica) Paciente con número cuarenta y siete, acuda a la consulta de triaje.

Petra: (Se levanta, se pone el abrigo) Mi padre tenía el cuarenta y siete aquella noche. Lo tengo guardado en la cartera, el papelito. (Lo saca, lo mira, lo vuelve a guardar) Vámonos. Aquí ya no tengo nada que hacer.